

Nombre del Prestador :	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
Seguro	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Nombre del Paciente	MURILLO ZAMBRANO NIBALDO FABRICIO
Cedula de identidad	1310005804
Historia Clínica	05804
Fecha de Ingreso	2025-10-11
Fecha de Egreso	2025-10-11
Procedimiento	POEM (MIOTOMIA PER ORAL ENDOSCOPICA)
Diagnostico	(K220) ACALASIA DEL CARDIAS
PLANILLA DE CARGOS DEL PROVEEDOR(CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA)	

HONORARIOS MEDICOS								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-11	43331	ESOFAGOMIOTOMIA (HELLER), VIA TORACICA.	1	\$307,78	\$307,78	\$0,00	\$0,0000	\$307,78
2025-10-11	43331	ESOFAGOMIOTOMIA (HELLER), VIA TORACICA.	1	\$181,80	\$181,80	\$0,00	\$0,0000	\$181,80
2025-10-11	43331	TIEMPO DE ANESTESIA	8	\$12,12	\$96,96	\$0,00	\$0,0000	\$96,96
2025-10-11	43235	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, DIAGNOSTICA, CON O SIN RECOLECCION DE MUESTRAS POR CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	1	\$33,66	\$33,66	\$0,00	\$0,0000	\$33,66
2025-10-11	43236	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON INYECCION (ES) DIRECTA SUBMUCOSA, CUALQUIER SUSTANCIA.	1	\$34,46	\$34,46	\$0,00	\$0,0000	\$34,46
2025-10-11	43255	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON CONTROL DE HEMORRAGIA, CUALQUIER METODO.	1	\$54,50	\$54,50	\$0,00	\$0,0000	\$54,50
Total			HONORARIOS MEDICOS					\$709,16

MEDICINAS - VALOR AL ORIGEN								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-11		SEVOFLURANO INHALACION. SOLUCION PARA INHALACION 1 MG/ML. PRESENT. 250ML	99	\$0,86	\$85,14	\$0,00	\$0,0000	\$85,14
2025-10-11		LACTATO RINGER LIQUIDO PARENTERAL PARA INFUSION ND 1000 ML. PRESENT. 1000 ML (1000ML)	1	\$1,93	\$1,93	\$0,00	\$0,0000	\$1,93
2025-10-11		GENTAMICINA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCIÓN INYECTABLE 140 MG/ML	4	\$1,02	\$4,08	\$0,00	\$0,0000	\$4,08
2025-10-11		PROPOFOL LIQUIDO PARENTERAL EMULSION INYECTABLE 10 MG / ML AMPOLLA/FRASCO. PRESENT. 200MG/20 ML	40	\$1,04	\$41,60	\$0,00	\$0,0000	\$41,60
2025-10-11		ROCURONIO, BROMURO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML PRESENT 50MG/5ML	1	\$10,29	\$10,29	\$0,00	\$0,0000	\$10,29
2025-10-11		LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 2% PRESENT. 10 ML	1	\$1,32	\$1,32	\$0,00	\$0,0000	\$1,32
2025-10-11		BUTIL ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA) - LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 20MG / ML PRESENT.20MG	1	\$1,27	\$1,27	\$0,00	\$0,0000	\$1,27
2025-10-11		ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 8MG PRESENT.8MG/4ML	1	\$3,02	\$3,02	\$0,00	\$0,0000	\$3,02
2025-10-11		FENTANILO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 0,05MG/10ML	1	\$0,25	\$0,25	\$0,00	\$0,0000	\$0,25
2025-10-11		DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 4 MG / ML PRESENT. 4MG/ML	2	\$0,34	\$0,68	\$0,00	\$0,0000	\$0,68
2025-10-11		CEFTRIAXONA SOLIDO PARENTERAL POLVO PARA INYECCION 1G PRESENT. 1GR	1	\$7,63	\$7,63	\$0,00	\$0,0000	\$7,63
2025-10-11		ATROPINA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 1 MG - ML PRESENT. 1ML	1	\$0,45	\$0,45	\$0,00	\$0,0000	\$0,45
2025-10-11		NEOSTIGMINA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 0,5 MG / ML PRESENT 0,5 MG /1ML	4	\$0,64	\$2,56	\$0,00	\$0,0000	\$2,56
2025-10-11		KETOROLACO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 30 MG / ML PRESENT. 30 MG	2	\$2,15	\$4,30	\$0,00	\$0,0000	\$4,30
2025-10-11		OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG	1	\$5,46	\$5,46	\$0,00	\$0,0000	\$5,46
2025-10-11		CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION PARA INFUSION 0,9 % 500 ML. PRESENT 500 ML	1	\$1,25	\$1,25	\$0,00	\$0,0000	\$1,25
2025-10-11		CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION PARA INFUSION 0,9 % 1000 ML . PRESENT 1000 ML	1	\$1,93	\$1,93	\$0,00	\$0,0000	\$1,93
Total			MEDICINAS - VALOR AL ORIGEN					\$173,16

INSUMOS - VALOR AL ORIGEN								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-11		OXIGENO LITROS MINUTO	600	\$0,01	\$6,00	\$0,00	\$0,0000	\$6,00
2025-10-11		Aguja de Esclerosis 22 G Long 4mm/ Diam catéter 2.3mm Long 2300 Estéril. Descartable	1	\$170,00	\$187,00	\$17,00	\$28,0500	\$215,05
2025-10-11		FLUSHKNIFE BALL TIP TYPE - 2.0 MM DK2618J-B20 DESCARTABLE	1	\$584,00	\$642,40	\$58,40	\$96,3600	\$738,76
2025-10-11		Lockado Clip 22 mm Rotable, Reposicionable. Long 235 Canal de Trabajo 2.8 mm Estéril. Descartable	1	\$400,00	\$440,00	\$40,00	\$66,0000	\$506,00
2025-10-11		Lockado Clip 16 mm Rotable, Reposicionable. Long 235 Canal de Trabajo 2.8 mm Estéril. Descartable	1	\$400,00	\$440,00	\$40,00	\$66,0000	\$506,00
2025-10-11		Lockado Clip 16 mm Rotable, Reposicionable. Long 235 Canal de Trabajo 2.8 mm Estéril. Descartable	1	\$400,00	\$440,00	\$40,00	\$66,0000	\$506,00
2025-10-11		Lockado Clip 16 mm Rotable, Reposicionable. Long 235 Canal de Trabajo 2.8 mm Estéril. Descartable	1	\$400,00	\$440,00	\$40,00	\$66,0000	\$506,00
2025-10-11		BlueBoost Solucion inyectable para la submucosa. 10ml . Estéril.	1	\$120,00	\$132,00	\$12,00	\$19,8000	\$151,80
2025-10-11		BlueBoost Solucion inyectable para la submucosa. 10ml . Estéril.	1	\$120,00	\$132,00	\$12,00	\$19,8000	\$151,80
2025-10-11		BlueBoost Solucion inyectable para la submucosa. 10ml . Estéril.	1	\$120,00	\$132,00	\$12,00	\$19,8000	\$151,80
2025-10-11		BlueBoost Solucion inyectable para la submucosa. 10ml . Estéril.	1	\$120,00	\$132,00	\$12,00	\$19,8000	\$151,80
2025-10-11		BlueBoost Solucion inyectable para la submucosa. 10ml . Estéril.	1	\$120,00	\$132,00	\$12,00	\$19,8000	\$151,80
2025-10-11		BlueBoost Solucion inyectable para la submucosa. 10ml . Estéril.	1	\$120,00	\$132,00	\$12,00	\$19,8000	\$151,80
2025-10-11		CAP REVEAL 12.4 MM DESCARTABLE	1	\$20,00	\$22,00	\$2,00	\$3,3000	\$25,30
2025-10-11		Ensure Coagulation Forceps, cucharas tapered jaw, apertura 6.5mm,Diam 2.3mm, long catéter 1650mm. Estéril, Descartable	1	\$760,00	\$836,00	\$76,00	\$125,4000	\$961,40
2025-10-11		KIT-CIRCUITO DE ANESTESIA DESCARTABLE	1	\$13,00	\$14,30	\$1,30	\$2,1450	\$16,45
2025-10-11		ELECTRODOS 3M DESCARTABLE	3	\$0,28	\$0,93	\$0,08	\$0,1395	\$1,07
2025-10-11		BOLSA DE SUCCION DESCARTABLE	1	\$4,50	\$4,95	\$0,45	\$0,7425	\$5,69
2025-10-11		EQUIPO VENOCLISIS DESCARTABLE	1	\$0,29	\$0,32	\$0,03	\$0,0480	\$0,37
2025-10-11		CATETER N°20 DESCARTABLE	1	\$0,75	\$0,83	\$0,08	\$0,1245	\$0,95
2025-10-11		MANGUERA DE SUCCION N°14 DESCARTABLE	1	\$2,75	\$3,03	\$0,28	\$0,4545	\$3,48
2025-10-11		JERINGAS DE 10 ML DESCARTABLE	2	\$0,11	\$0,24	\$0,02	\$0,0360	\$0,28
2025-10-11		JERINGAS DE 20 ML DESCARTABLE	2	\$0,18	\$0,40	\$0,04	\$0,0600	\$0,46
2025-10-11		Bite Block Adulto DESCARTABLE	1	\$8,00	\$8,80	\$0,80	\$1,3200	\$10,12
2025-10-11		SONDA DE SUCCION N°14 DESCARTABLE	1	\$0,90	\$0,99	\$0,09	\$0,1485	\$1,14
2025-10-11		BATA PACIENTE DESCARTABLE	1	\$1,20	\$1,32	\$0,12	\$0,1980	\$1,52
2025-10-11		BATA QUIRURGICA M DESCARTABLE	3	\$1,30	\$4,29	\$0,39	\$0,6435	\$4,93
2025-10-11		GORRO QUIRURGICOS DESCARTABLE	4	\$0,02	\$0,08	\$0,01	\$0,0120	\$0,09
2025-10-11		MASCARILLA QUIRURGICAS DESCARTABLE	4	\$0,02	\$0,08	\$0,01	\$0,0120	\$0,09
2025-10-11		ZAPATONES DESCARTABLE	8	\$0,20	\$1,76	\$0,16	\$0,2640	\$2,02

INSUMOS - VALOR AL ORIGEN								
2025-10-11		GUANTES MANEJO M-S DESCARTABLE	6	\$0,07	\$0,48	\$0,04	\$0,0720	\$0,55
2025-10-11		TEGADERM APOSITO DE FIJACION DESCARTABLE	1	\$0,70	\$0,77	\$0,07	\$0,1155	\$0,89
2025-10-11		LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENCION DESCARTABLE	1	\$0,30	\$0,33	\$0,03	\$0,0495	\$0,38
2025-10-11		TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0MM DESCARTABLE	1	\$1,85	\$2,04	\$0,19	\$0,3060	\$2,35
Total			INSUMOS - VALOR AL ORIGEN					\$4 934,14
LABORATORIO								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
Total			LABORATORIO					\$0,00
IMAGEN(*)								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
Total			IMAGEN(*)					\$0,00
SERVICIOS INSTITUCIONALES								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-11	395162	DERECHOS DE SALA INST. SEGUNDO NIVEL	1	\$46,90	\$46,90	\$0,00	\$0,0000	\$46,90
2025-10-11	395272	SALA DE RECUPERACION. INSTITUCIONES SEGUNDO NIVEL	1	\$26,80	\$26,80	\$0,00	\$0,0000	\$26,80
Total			SERVICIOS INSTITUCIONALES					\$73,70
EQUIPOS ESPECIALES								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
Total			EQUIPOS ESPECIALES					\$0,00
TOTAL LIQUIDACION								\$5 890,16



.....
DRA. AURA EDITH ZAMBRANO PAREDES
C.I. 0926862152
JEFE DE CONVENIOS PÚBLICOS
DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA
PRESTADOR EXTERNO

SERVICIO GASTROENTEROLOGIA	Fecha de Elaboración:	2025-10-11
	Área-Proceso:	AUDITORIA MEDICA
INFORME TÉCNICO-MÉDICO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES A LAS AUTORIZADAS		Página: 1

DATOS GENERALES	
NOMBRES Y APELLIDOS DE PACIENTE:	NIBALDO FABRICIO MURILLO ZAMBRANO
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1310005804
CÓDIGO DE VALIDACIÓN QUE AUTORIZÓ PRESTACIÓN:	CVA02102025JKAS00353
FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE:	2025-10-11
MÉDICO SOLICITANTE:	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
ESPECIALIDAD / SUBESPECIALIDAD:	GASTROENTEROLOGO

DIAGNÓSTICOS (CIE-10):	
DIAGNÓSTICO(S) QUE JUSTIFICARON EL CÓDIGO DE VALIDACIÓN:	K220 ACALASIA DEL CARDIAS
DIGANÓSTICOS ACTUALES QUE JUSTIFICARÁN LA PRESTACIÓN ADICIONAL:	K220 ACALASIA DEL CARDIAS

CUADRO CLÍNICO DEL PACIENTE QUE JUSTIFICARÁ PRESTACIÓN ADICIONAL	
PACIENTE MASCULINO DE 49 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CIRUGÍA DE REPARACIÓN DE HERNIA HIATAL, CIRUGÍA ANTIRREFLUJO. PRESENTA CUADRO DE DISFAGIA, VÓMITOS, PÉRDIDA DE PESO. EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, EL CUADRO SE EXACERBO EN LOS ÚLTIMOS 20 DÍAS. INFORME DE ESOFAGOGRAMA: ESÓFAGO DILATADO DE 7 CMS CON PERSISTENCIA DEL MEDIO DE CONTRASTE. SE REALIZA ENDOSCOPIA ALTA IECED PORTOVIEJO: 23/06/2025 CON HALLAZGOS ESÓFAGO CON RETENCIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS ESÓFAGO SIGMOIDEO, PROBABLE TRASTORNO MOTOR ESOFÁGICO ESTOMAGO EN RELACIÓN A SU ANTECEDENTE QUIRÚRGICO GASTROPATÍA ERITEMATOSA EN CUERPO Y ANTRO TEST DE UREASA PARA H. PYLORI NEGATIVO. MANOMETRIA 25/7/2025: AUSENCIA DE PERISTALSIS CON PRESURIZACIÓN PANESOFAGICA INDUCIDA POR LAS DEGLUCIONES. PRESIÓN BASAL NORMAL DEL ESFÍNTER ESOFAGICO INFERIOR LOS HALLAZGOS CARACTERIZAN UNA ACALASIA DEL TIPO II POR LA CLASIFICACIÓN DE CHICAGO APP: ACALASIAAPF: MADRE HTA- TIO MATERNO CA DE COLON (+)APQX: CIRUGIA DE REPARACION DE HERNIA HIATAL, CIRUGIA ANTIRREFLUJOALERGIAS: NO REFIERE LABORATORIOS : HGB 15.2 HCT 44.9 PLT 288 , TIEMPOS NORMALES , GLUCOSA 99.8, ENZIMAS HEPATICAS OK . ELECTROLITOS ELEVACIÓN DEL POTASIO EN SUERO 6.79 CLORO 95.10 SODIO 135.8 , UREA 31.6 BUN 14.7 CREATININA 1.2 VALORACIÓN CARDIOLÓGICA : RIESGO BAJO POR SCORE LEE Diagnostico: K220 ACALASIA DEL CARDIAS Conclusion: ACALASIA + MIOTOMIA ENDOSCOPICA SIN COMPLICACIONES INMEDIATAS EN PACIENTE CON HELLER PREVIO.	

PROTOCOLOS UTILIZADOS QUE JUSTIFICAN LA PRESTACIÓN ADICIONAL REALIZADA:					
NO.	PROTOCOLOS	TIPO * (SELECCIONE CON UNA X)			OBSERVACIONES
		NAC	INTERN.	MBE	
1	Miotomía de Heller por vía laparoscópica: un procedimiento seguro		X	X	Borráz BA, Patti MG. Miotomía de Heller por vía laparoscópica: un procedimiento seguro. Rev Colomb Cir. 2014;29:182-87.
2	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Unidad de Coordinación para la Formulación y Elaboración de Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Atención PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA ACALASIA		X	X	1. Goldman, Pocket Guide to the Operating Room Philadelphia: F.A. Davis Company. M.A. (3rd e.). (2008). 2. Katz PO, Gerson LB, Vela MF. Pautas para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Am J Gastroenterol. 2013 Mar; 108 (3): 308- 28. [184 referencias] PubMed 3. Longstreth, Achalasia. G.F. MD (2012). http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000267.htm . 4. Stefanidis D, W Richardson, Farrell TM, Kohn GP, Augenstein V, Fanelli RD. SAGES directrices para el tratamiento quirúrgico de la acalasia esofágica. Los Ángeles (CA): Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos (sabios); 2011 mayo. 50 p. [128 referencias] 5. Vaezi MF, Pandolfino JE, Vela MF. ACG guía clínica: diagnóstico y tratamiento de la acalasia. Am J Gastroenterol. 2013 Aug; 108 (8): 1238 a 1249. [103 referencias]
3	PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA AGUDA DEL TUBO DIGESTIVO ALTO NO VARICEAL, EN LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN		X	X	CATALOGO MAESTRO ISSSTE-133-08
4	Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento del Adenocarcinoma Gástrico en Pacientes Adultos Evidencias y Recomendaciones Catalogo Maestro de Guías de Práctica Clínica: IMSS-167-09		X	X	1. Aapro MS, Grunberg SM, Manikhas GM et al. A phase III, double-blind, randomized trial of palonosetron compared with ondansetron in preventing chemotherapy-induced nausea and vomiting following highly emetogenic chemotherapy. Ann Oncol 2006; 17: 1441–1449. 3. Bjelakovic G, Nikolova D, Simonetti RG, Gluud C. Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004 Issue 4.
5	lesión gástrica posible neoplasia.		X	X	Clinical impact of confocal laser endomicroscopy in the management of gastrointestinal lesions with an uncertain diagnosis. World J Gastrointest Endosc. 2017 Aug 16;9(8):389-395. doi: 10.4253/wjge.v9.i8.389.
6	Miotomía de Heller por vía laparoscópica: un procedimiento seguro		X	X	Borráz BA, Patti MG. Miotomía de Heller por vía laparoscópica: un procedimiento seguro. Rev Colomb Cir. 2014;29:182-87.

7	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Unidad de Coordinación para la Formulación y Elaboración de Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Atención PROTOCOLO DE ATENCION PARA ACALASIA		X	X	1. Goldman, Pocket Guide to the Operating Room Philadelphia: F.A. Davis Company. M.A. (3rd e.). (2008). 2. Katz PO, Gerson LB, Vela MF.Pautas para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofagico. Am J Gastroenterol. 2013 Mar; 108 (3): 308- 28. [184 referencias] PubMed 3. Longstreth, Achalasia. G.F. MD (2012). http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000267.htm . 4. Stefanidis D, W Richardson, Farrell TM, Kohn GP, Augenstein V, Fanelli RD. SAGES directrices para el tratamiento quirúrgico de la acalasia esofágica. Los Ángeles (CA): Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos (sabios); 2011 mayo.50 p. [128 referencias] 5. Vaezi MF, Pandolfino JE, Vela MF. ACG guía clínica: diagnóstico y tratamiento de la acalasia. Am J Gastroenterol. 2.013 Aug; 108 (8): 1238 a 1249. [103 referencias]
*TIPO: NACIONALES (NAC), INTERNACIONALES (INTERN), BUENAS PRACTICAS MÉDICAS BASADAS EN MEDICNA BASADA EN EVIDENCIA (MBE)					

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES AL AUTORIZADO QUE SERÁN JUSTIFICADOS CON ESTE INFORME:			
NO.	COD. TARIFARIO	DESCRIPCIÓN	
1	43331	ESOFAGOMIOTOMIA (HELLER), VIA TORACICA.	
2	43235	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, DIAGNOSTICA, CON O SIN RECOLECCION DE MUESTRAS POR CEPILLADO O LAVADO (PROCEDIMIENTO SEPARADO).	
3	43236	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON INYECCION (ES) DIRECTA SUBMUCOSA, CUALQUIER SUSTANCIA.	
4	43255	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON CONTROL DE HEMORRAGIA, CUALQUIER METODO.	
Nota: Este informe no justifica la prescripción de medicamentos fuera del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos sin la autorización debida según la normativa legal vigente para el caso, Homologaciones de procedimientos y/o laboratorios no autorizadas por el Ministerio de Salud Pública, facturación indebida de acuerdo al Tarifario de Prestaciones de Salud pertinente y otras situaciones de igual similitud.			
	NOMBRE	CARGO/ESPECIALIDAD	FIRMA Y SELLO
Elaborado por:	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	GASTROENTEROLOGO	 Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO cedula No. 1307189140

CÉDULA DE
IDENTIDAD



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CONDICIÓN CIUDADANÍA

APELLIDOS

MURILLO

ZAMBRANO

NOMBRES

NIBALDO FABRICIO

NACIONALIDAD

ECUATORIANA

FECHA DE NACIMIENTO

07 ABR 1976

LUGAR DE NACIMIENTO

MANABI PORTOVIEJO

PORTOVIEJO

FIRMA DEL TITULAR

SEXO

HOMBRE

No. DOCUMENTO

077908164

FECHA DE VENCIMIENTO

08 FEB 2034

NAT/CAN

419303

NUI.1310005804

Nibaldo Murillo



APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

MURILLO MURILLO JACINTO AGUSTIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

ZAMBRANO ORMAZA ANGELA FLORA

ESTADO CIVIL

SOLTERO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

ROCAFUERTE 08 FEB 2024

CÓDIGO DACTILAR

V2333V2242

TIPO SANGRE O+

DONANTE

SI

DIRECTOR GENERAL



I<ECU0779081648<<<<<1310005804
7604072M3402085ECU<SI<<<<<<<6
MURILLO<ZAMBRANO<<NIBALDO<FABR

Fecha: Guayaquil, 11 de Septiembre del 2025

Nombre: NIBALDO FABRICIO MURILLO ZAMBRANO

CI. 1310005804

Edad: 50 años

Alergia: NO

Rp:

-Cefur (Cefuroxima) 500 mg: tabletas N° 10 (diez)

-Metronidazol (Etron 500 mg): cápsulas N° 21 (veintiuno)

-Ondasetron 4 mg (Vonau Flash 4 mg): Tabletetas N° 8 (ocho)

-Omeprazol + Bicarbonato de Na (Ulcozol rapid): 30 (treinta)

-Ketorolaco (Dolgenal rapid) 10 (diez)

-PARACETAMOL (UMBRAL JARABE 150MG/5ML): # 3 frascos

DX ACALASIA



Dr. Carlos Antonio Robles Medranda
GASTROENTEROLOGO
C.I 1307189140

Fecha: Guayaquil, 11 de Septiembre del 2025

Nombre: NIBALDO FABRICIO MURILLO ZAMBRANO

CI. 1310005804

Edad: 50 años

Alergia: NO

Prescripción:

-Cefur 1 tableta 8 am y 8 pm

-Metronidazol (ETRON) 500 mg: 1 capsula cada 8 horas

-Ondasetron 4 mg (Modifical 4 mg): 1 tableta cada 12 horas

-Omeprazol + Bicarbonato de Na (Ulcozol Rapid): 1 sobre disuelto en agua antes del desayuno y merienda

-Ketorolaco (Dolgenal rapid): 1 tab debajo de la lengua de mañana, tarde o noche en caso de dolor

-PARACETAMOL (UMBRAL JARABE 150MG/5ML): TOMAR 2 cucharadas cada 6/h. (6am, 12m, 6pm, 11pm)

Todas las tabletas deben ser molidas previa administración/consumo

Citas médicas



042109180 - 0983753477 -0991051413/0986637750



Av. Abel R. Castillo S/N y Av. Juan Tanca Marengo,
Torre Médica I, mezanine 3, y Torre Medica II, piso 4,
consultorios 405 - 406, Ciudad del Sol(Omnihospital)

Medios Digitales



www.ieced.com.ec



@Ieced

Citas médicas



042109180 - 0983753477 -0991051413/0986637750



Av. Abel R. Castillo S/N y Av. Juan Tanca Marengo,
Torre Médica I, mezanine 3, y Torre Medica II, piso 4,
consultorios 405 - 406, Ciudad del Sol(Omnihospital)

Medios Digitales



www.ieced.com.ec



@Ieced

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE

INSTITUCION DEL SISTEMA	UNICODIGO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA			NÚMERO DE ARCHIVO				
PARTICULAR	26699	DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA	1310005804							
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
							H	D	M	A
MURILLO		ZAMBRANO	NIBALDO	FABRICIO	Masculino	50				x

B. DIAGNÓSTICOS

Post Operatorio:	1	ACALASIA DEL CARDIAS	CIE
			K220

C. PROCEDIMIENTO

	Electiva	X	Emergencia		Urgencia	
Proyectado:	POEM (MIOTOMIA PER ORAL ENDOSCOPICA)					
Realizado:	POEM (MIOTOMIA PER ORAL ENDOSCOPICA)					

D. INTEGRANTES DEL EQUIPO QUIRÚRGICO

Cirujano 1:	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	Instrumentista:	
Cirujano 2:		Circulante:	
Primer Ayudante:	Dr(a). DEL VALLE ZAVALA RAQUEL SALOME	Anestesiologo/a:	Dr(a). ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA
Segundo Ayudante:		Ayudante Anestesia:	
Tercer Ayudante:		Otros:	

E. TIPO ANESTESIA

General		Regional		Sedación		Otros	
---------	--	----------	--	----------	--	-------	--

F. TIEMPOS QUIRÚRGICOS

FECHA DE OPERACIÓN		DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACION
		11	09	2025	07:00:00	09:00:00
Dieresis:						
Exposición y Exploración:						
Hallazgos Quirúrgicos:						
ACALASIA + MIOTOMIA ENDOSCOPICA SIN COMPLICACIONES INMEDIATAS EN PACIENTE CON HELLER PREVIO.						
Procedimiento Quirúrgico:						

BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE VIDEOENDOSCOPIO TERAPEUTICOACOPADO AL CAP REVEAL 12.4 MM DESCARTABLE A TRAVES DEL BITE BLOCK ADULTO DESCARTABLEPOR VIA ORAL. EL ESOFAGO SE ENCUENTRA DILATADO TORTUOSO CON DIFICULTAD DEL PASO DEL ENDOSCOPIO. EL ESTOMAGO MUESTRA EL TECHO NORMAL CON MORFOLOGIA DE FUNDUPPLICATURA, EL CUERPO NORMAL. EL ANTRO PRESENTA ERITEMA. EL BULBO ESTA NORMAL. LA SEGUNDA PORCION SIN LESIONES EL CARDIAS ESTA A 42CM DE LA ARCADA DENTARIA SUPERIOR APROXIMADAMENTE. SE REALIZA LAVADO DE LA MUCOSA ESOFAGICA CONUNA AMPOLLA DE GENTAMICINA DE 280MG DILUIDA EN 60 CC DE CLORURO DE SODIO. UTILIZANDO UN FLUSHKNIFE BALL TIP TYPE - 2.0 MM DK2618J-B20 DESCARTABLEACOPADO UNA BOMBA PLUS PARA ERBEJETT DESCARTABLE Y ESTE A SU VEZ ACOPLADO CON EL SET DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ENDOCORTE DESCARTABLE PROCEDEMOS REALIZAR UN TUNEL CON ABERTURA DE 1,5CM APROXIMADAMENTE A 7CM POR ENCIMA DEL CARDIAS SOBRE CARA POSTERIOR. LUEGO SE PROCEDE CON UNA Aguja de Esclerosis 22 G Long 4mm/ Diam catéter 2.3mm Long 2300 Estéril. DescartableA INYECTAR CLORURO DE SODIO CON AZUL DE METILENO EN LA SUBMUCOSA (6 BlueBoost Solucion inyectable para la submucosa. 10ml . Estéril) SE PROCEDE A SEGUIR REALIZANDO CORTE Y COAGULACION DE SUBMUCOSA Y COAGULACION DE LOS VASOS SANGUINEOS DE PEQUEÑO CALIBRE, HASTA COMPLETAR UN TUNEL EN LA SUBMUCOSA. CON UNA PINZEnsure Coagulation Forceps, cucharas tapered jaw, apertura 6.5mm,Diam 2.3mm, long catéter 1650mm. Estéril, DESCARTABLE ACOPLADO AL SET DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ENDOCORTE DESCARTABLE SE CAUTERIZA VASOS SANGUINEOS DE MAYOR CALIBRE. POSTERIORMENTE SE REALIZA CORTE DE LA FIBRA MUSCULAR Y LONGITUDINAL DEL ESOFAGO HASTA LLEGAR AL CARDIAS LUEGO SE LAVA CON UNA SEGUNDAAMPOLLA DE GENTAMICINA DE 280MG DILUIDA EN 60 CC DE CLORURO DE SODIO EL INTERIOR DEL TUNEL REALIZADO. LUEGO DE COMPRUEBA EL PASO DEL ENDOSCOPIO DESDE EL ESOFAGO A ESTOMAGO SIN NINGUNA DIFICULTAD A NIVEL DEL CARDIAS. FINALMENTE SE COLOCAN8 Lockado Clip 16 mm Rotable, Reposicionable. Long 235 Canal de Trabajo 2.8 mm Estéril. DescartableY 1Lockado Clip 22 mm Rotable, Reposicionable. Long 235 Canal de Trabajo 2.8 mm Estéril. Descartable PARA CERRAR LA TOTALIDAD DEL TUNEL EVIDENCIANDOSE HEMOSTASIA Y CIERRE ADECUADO.

G. COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

NO

Pérdida Sanguínea total:

ml

Muestra:

Descripción:

H. EXÁMENES HISTOPATOLÓGICOS

Transquirúrgico:

Biopsia por congelación:

SI

NO

Resultado:

Patólogo que reporta:

Histopatológico:

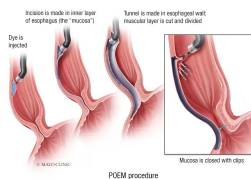
SI

NO

x

Muestra :

I. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO



J. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS	ESPECIALIDAD	FIRMA	SELLO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	GASTROENTEROLOGO		Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO cedula No. 1307189140

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE

INSTITUCION DEL SISTEMA				ESTABLECIMIENTO DE SALUD				NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA				NÚMERO DE ARCHIVO			
PARTICULAR				DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA				1310005804							
PRIMER APELLIDO			SEGUNDO APELLIDO			PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE		SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
MURILLO			ZAMBRANO			NIBALDO		FABRICIO		Masculino	50	H	D	M	A
FECHA	2025-10-11	TALLA	0	PESO KG	0	IMC		GRUPO Y FACTOR		CONSENTIMIENTO INFORMADO	SI		NO		

B. SERVICIO Y PRIORIDAD DE ATENCION

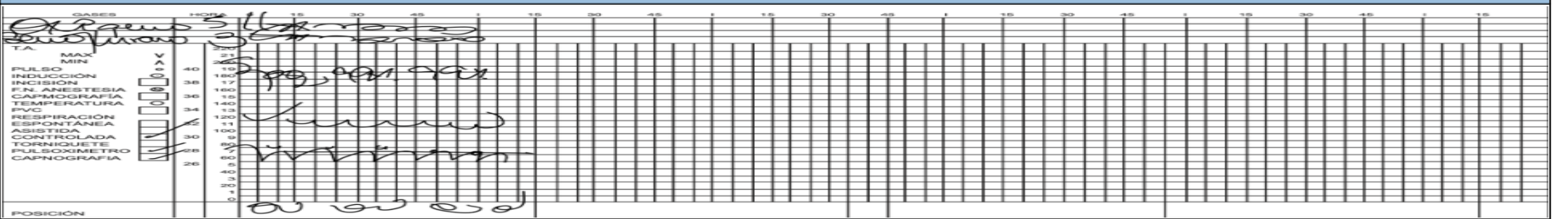
DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO		CIE		CIRUGÍA PROPUESTA		POEM	ESPECIALIDAD	PRIORIDAD	EMERGENTE
DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO		ACALASIA DEL CARDIAS		CIE	K220	CIRUGÍA REALIZADA	POEM		URGENTE
ANESTESIOLOGO	ANGELICA MARIA ARRIETA BRICEÑO	AYUDANTE (S)		VERENA ELIZABETH TANDAZO VALAREZO		INSTRUMENTISTA	MILENA ASTRID RIERA HOLGUIN		ELECTIVO
CIRUJANO	CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA	AYUDANTE (S)		RAQUEL SALOME DEL VALLE ZAVALA		CIRCULANTE			X

OTROS

C. SERVICIO Y PRIORIDAD DE ATENCION

CABEZA		ÓRGANOS		CUELLO		COLUMNA		TÓRAX		ABDÓMEN	X	PELVIS		EXT.SUPERIORES		EXT.INFERIORES		PERINEAL	
--------	--	---------	--	--------	--	---------	--	-------	--	---------	---	--------	--	----------------	--	----------------	--	----------	--

D. REGISTRO TRANSANESTÉSICO



E. DROGAS ADMINISTRADAS															
1	PROPOFOL 200MG/20ML (600MG)			2	BROMURO DE ROCURONIO 10MG/ML (10MG)			3	LIDOCAINA S/E 2% (20MG)			4	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/ML (20MG)		
5	ONDANSETRON 8MG/4ML (8MG)			6	FENTANILO 0.05MG/10ML (150MCG)			7	DEXAMETASONA LÍQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (8MG)			8	CEFTRIAXONA: 1G		
9	ATROPINA 1MG/ML - NEOSTIGMINA 0.5MG/ML (2MG)			10	KETOROLACO 30MG/ML (60MG)			11	OMEPRAZOL 40MG			12			
13				14				15				16			

F. TÉCNICA ANESTÉSICA

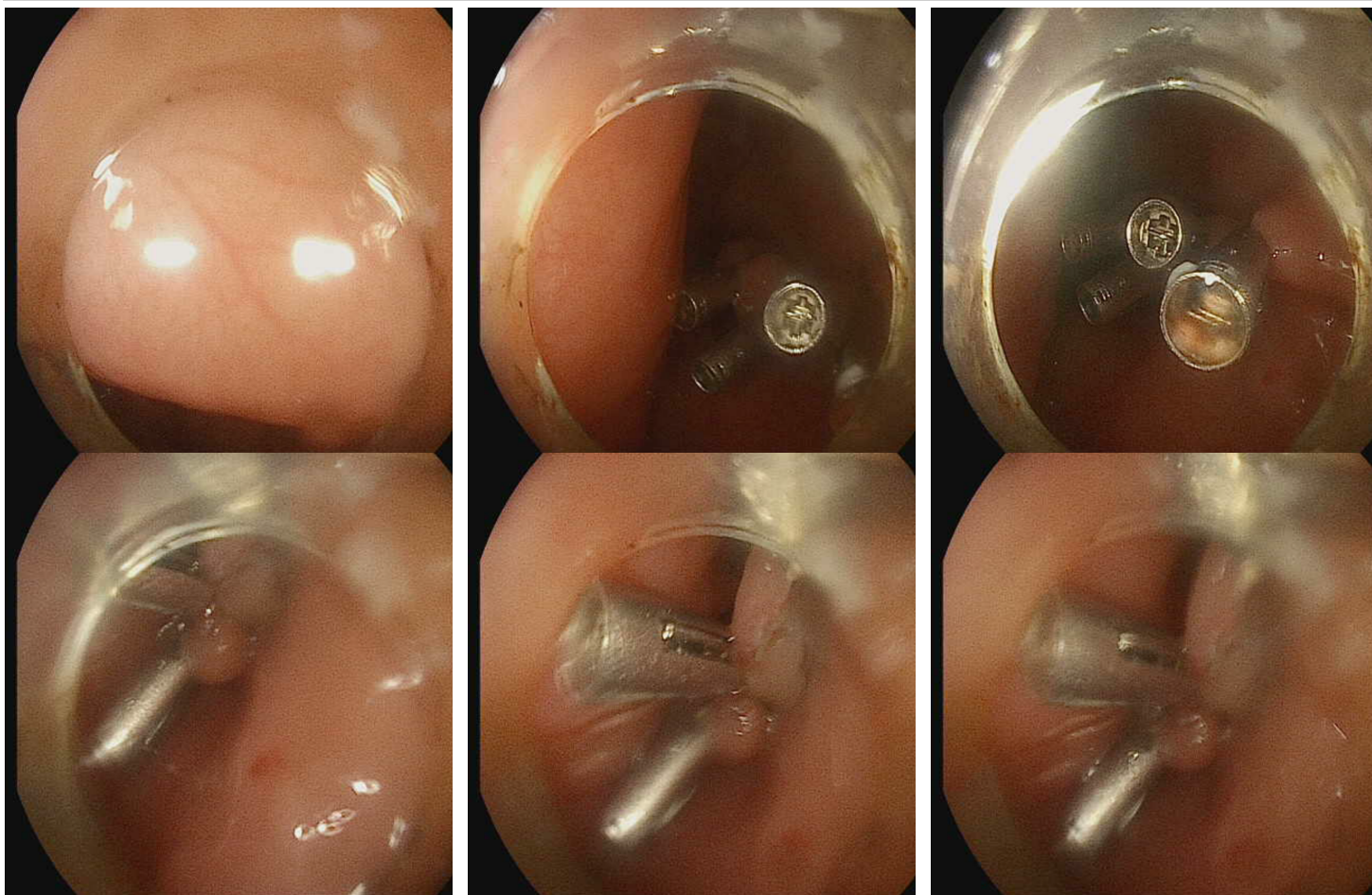
GENERAL												REGIONAL												SEDO - ANALGESIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SISTEMA						APARATO						ASEPSIA CON						HABÓN CON																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ABIERTO		CERRADO	X	SEMICERRADO		CIRCUITO CIRCULAR		UNIDIRECCIONAL		LOCAL ASISTIDA				INTRAVENOSA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

G. ACCESOS VASCULARES			H. REPOSICIÓN VOLÉMICA			I. PÉRDIDAS		
TIPO	CALIBRE	SITIO	DEXTROSA 5%		SANGRE		SANGRADO	
IV PERIFÉRICO 1	20	Miembro superior derecho	DEXTROSA 10%		PLASMA		DIURESIS	
IV PERIFÉRICO 2			DEXTROSA 50%		PLAQUETAS		OTROS	
IV PERIFÉRICO 3			DEXTROSA EN SS		CRIOPRECIPITADOS		TOTAL	
IV CENTRAL			SS 0.9%	1000	OTROS			
INTRA ARTERIAL			LACTO RINGER	1000				
OTRO			EXPANSORES		TOTAL	1750	BALANCE	

J. DATOS DEL RECIENTE NACIDO										K. TIEMPOS TRANSCURRIDOS									
APGAR	X	FETO MUERTO			1 MINUTO			5 MINUTOS		10 MINUTOS		DURACION ANESTESIA	02:00:00	DURACION CIRUGIA		02:00:00			

L. TECNICAS ESPECIALES															
HEMODILUCIÓN			AUTOTRANSFUSIÓN			HIPOTENSIÓN			HIPOTERMIA			CIRCULACIÓN EXTRACOPÓREA			
M. MANTENIMIENTO TEMPERATURA CORPORAL															
MANTA TERMICA			CALENTAMIENTO DE FLUIDOS			OTROS									
N. INCIDENTES															
ACTIVIDAD ELÉCTRICA SIN PULSO			ARRITMIA			ASISTOLIA			TRMBOEMBOLIA						
HIPERTERMIA MALIGNA			ANAFILAXIA			ISQUEMIA MIOCÁRDICA			NEUMOTÓRAX						
BRONCOESPASMO			DESPERTAR PROLONGADO			EMBOLIA AÉREA VENOSA			LARINGOESPASMO						
DIFICULTAD DE LA TÉCNICA			OTROS												
O. RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO															
HORA	pH	PO2	PCO2	HCO3	EB	SAT. O2	LACTATO	GLUCOSA	Na	K	Cl	HCTO	HB	OTRO	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
P. OBSERVACIONES															
PACIENTE PASA A SALA DE RECUPERACIÓN EN CONDICIONES ESTABLES															
Q. CONDICIONES DE EGRESO															
CONDICIONES AL SALIR		EXTUBADO		CONDUCTIDO A	UNIDAD DE CUIDADOS POST ANESTÉSICO	X	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		CRÍTICOS DE EMERGENCIA		MORGUE				
		INTUBADO													
CONSTANTES VITALES DE ENTREGA		TA	108/70mmhg	FC	75	FR	14	SAT.O2		99	T°				
R. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE															
HORA	09:00:00	NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL	ANGELICA MARIA ARRIETA BRICEÑO			FIRMA	<i>Angelica M Arrieta B.</i>		SELLO Y CÓDIGO	Dra. ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA ANESTESIOLOGIA Cedula No. 1759345422					

Paciente:	MURILLO ZAMBRANO NIBALDO FABRICIO	Edad:	50 años	Identificacion:	1310005804
Procedimiento:	POEM (MIOTOMIA PER ORAL ENDOSCOPICA)				
Referido por:		Fecha:	11/09/2025		



Hallazgos

BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE VIDEOENDOSCOPIO TERAPEUTICO POR VIA ORAL CON UN **CAP DISECCIONDESCARTABLE** EN SU PUNTA. EL ESOFAGO SE ENCUENTRA DILATADO TORTUOSO CON DIFICULTAD DEL PASO DEL ENDOSCOPIO. EL ESTOMAGO MUESTRA EL TECHO NORMAL CON MORFOLOGIA DE FUNDUPLICATURA, EL CUERPO NORMAL. EL ANTRO PRESENTA ERITEMA. EL BULBO ESTA NORMAL. LA SEGUNDA PORCION SIN LESIONES. EL CARDIAS ESTA A 42CM DE LA ARCADA DENTARIA SUPERIOR APROXIMADAMENTE. SE REALIZA LAVADO DE LA MUCOSA ESOFAGICA CON UNA AMPOLLA DE GENTAMICINA DE 280MG DILUIDA EN 60 CC DE SOLUCION SALINA. UTILIZANDO EL **FLUSH KNIFE TIPO T DESCARTABLE** (2,3MM) DE 1,9MM DE LARGO ACOPLADO AL **KIT DE LA UNIDAD DE BOMBA DESCARTABLE ERBE JET** Y ESTE A SU VEZ ACOPLADO CON EL **SET DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ENDOCORTE** PROCEDAMOS REALIZAR UN TUNEL CON ABERTURA DE 1,5CM APROXIMADAMENTE A 7CM POR ENCIMA DEL CARDIAS SOBRE CARA POSTERIOR. LUEGO SE PROCEDE CON EL **INYECTOR ENDOSCOPICO DE ESCLEROTERAPIA DESCARTABLE** A INYECTAR SOLUCION SALINA CON AZUL DE METILENO EN LA SUBMUCOSA (6 AMPOLLAS DE BLUEBOOST) SE PROCEDE A SEGUIR REALIZANDO CORTE Y COAGULACION DE SUBMUCOSA Y COAGULACION DE LOS VASOS SANGUINEOS DE PEQUEÑO CALIBRE, HASTA COMPLETAR UN TUNEL EN LA SUBMUCOSA. CON LA **PINZA DE COAGULACION COAGRASPER DESCARTABLE** ACOPLADO AL **SET DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ENDOCORTE** SE CAUTERIZA VASOS SANGUINEOS DE MAYOR CALIBRE. POSTERIORMENTE SE REALIZA CORTE DE LA FIBRA MUSCULAR Y LONGITUDINAL DEL ESOFAGO HASTA LLEGAR AL CARDIAS. LUEGO SE LAVA CON UNA AMPOLLA DE GENTAMICINA DE 280MG DILUIDA EN 60 CC DE SOLUCION SALINA EL INTERIOR DEL TUNEL REALIZADO. LUEGO DE COMPRUEBA EL PASO DEL ENDOSCOPIO DESDE EL ESOFAGO A ESTOMAGO SIN NINGUNA DIFICULTAD A NIVEL DEL CARDIAS. FINALMENTE UTILIZANDO PINZA DE HEMOCLIPS SE COLOCAN 4 CLIPS DESCARTABLES PARA CERRAR LA TOTALIDAD DEL TUNEL EVIDENCIANDOSE HEMOSTASIA Y CIERRE ADECUADO.

Conclusiones

ACALASIA + MIOTOMIA ENDOSCOPICA SIN COMPLICACIONES INMEDIATAS EN PACIENTE CON HELLER PREVIO.

Dr. Carlos Antonio Robles Medranda
GASTROENTEROLOGO
C.I 1307189140

CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO USUARIO / PACIENTE

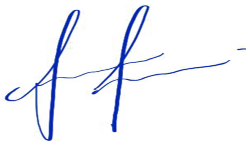
INSTITUCIÓN DEL SISTEMA	UNICODIGO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NUMERO DE HISTORIA CLINICA	NUMERO DE ARCHIVO		No.HOJA			
PARTICULAR	26699	DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA		1310005804						
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)				
						H	D	M	A	
MURILLO	ZAMBRANO	NIBALDO	FABRICIO	Masculino	50				x	

B. EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES

FIRMAR AL PIE DE CADA EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIÓN

REGISTRAR CON ROJO LA ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

1. EVOLUCIÓN			2. PRESCRIPCIONES	
FECHA (aaaa- mm - dd)	HORA (hh:mm)	NOTAS DE EVOLUCIÓN	FARMACOTERAPIA E INDICACIONES(Para enfermería y otro profesional de salud)	ADMINISTR. FARMACOS DISPOSITIVOS
11/09/2025	05:00	PACIENTE MASCULINO DE 49 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CIRUGÍA DE REPARACIÓN DE HERNIA HIATAL, CIRUGÍA ANTIRREFLUJO. PRESENTA CUADRO DE DISFAGIA, VÓMITOS, PÉRDIDA DE PESO. EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, EL CUADRO SE EXACERBO EN LOS ÚLTIMOS 20 DÍAS. INFORME DE ESOFAGOGRAMA: ESÓFAGO DILATADO DE 7 CMS CON PERSISTENCIA DEL MEDIO DE CONTRASTE. SE REALIZA ENDOSCOPIA ALTA IECED PORTOVIEJO:23/06/2025 CON HALLAZGOS ESÓFAGO CON RETENCIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS ESÓFAGO SIGMOIDEO, PROBABLE TRASTORNO MOTOR ESOFÁGICO ESTOMAGO EN RELACIÓN A SU ANTECEDENTE QUIRÚRGICO GASTROPATÍA ERITEMATOSA EN CUERPO Y ANTRO TEST DE UREASA PARA H. PYLORI NEGATIVO. MANOMETRIA 25/7/2025: AUSENCIA DE PERISTALSIS CON PRESURIZACIÓN PANESOFAGICA INDUCIDA POR LAS DEGLUCIONES. PRESIÓN BASAL NORMAL DEL ESFÍNTER ESOFAGICO INFERIOR LOS HALLAZGOS CARACTERIZAN UNA ACALASIA DEL TIPO II POR LA CLASIFICACIÓN DE CHICAGO APP: ACALASIA APF: MADRE HTA- TIO MATERNO CA DE COLON (+) APQX: CIRUGIA DE REPARACION DE HERNIA HIATAL, CIRUGIA ANTIRREFLUJO ALERGIAS: NO REFIERE LABORATORIOS : HGB 15.2 HCT 44.9 PLT 288 , TIEMPOS NORMALES , GLUCOSA 99.8, ENZIMAS HEPATICAS OK , ELECTROLITOS ELEVACIÓN DEL POTASIO EN SUERO 6.79 CLORO 95.10 SODIO 135.8 , UREA 31.6 BUN 14.7 CREATININA 1.2 VALORACIÓN CARDIOLÓGICA : RIESGO BAJO POR SCORE LEE	1.- CSV 2.- PREPARAR PARA PROCEDIMIENTO 3.- SOL SAL 0.9% 1000cc a 30gts x min 4.-SEGUIR INDICACIONES DE MEDICO RESIDENTE 5.-SE SOLICITA EXAMENES PRE-QUIRURGICOS	
11/09/2025	09:00	PASE A SALA DE RECUPERACIÓN DESPUÉS DE PROCEDIMIENTO CON SIGNOS VITALES ESTABLES.	1.- BUTIL BROMURO DE HIOSCINBA IV PRN 2.- SEGUIR INDICACIONES	
11/09/2025	10:00	PACIENTE EGRESA DE QUIROFANO ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE LUEGO DE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ENDOSCÓPICOS. PCTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO. SE MANTIENE ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE. CLÍNICAMENTE BIEN. ES DADA DE ALTA, SE EXPLICAN LOS RESULTADOS AL PACIENTE Y ACOMPAÑANTE. SE ENTREGAN INDICACIONES AL ALTA.		



Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
GASTROENTERÓLOGO
cedula No. 1307189140

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE									
INSTITUCIÓN DEL SISTEMA	UNICÓDIGO		ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA		NÚMERO DE ARCHIVO		No. HOJA
PARTICULAR	26699		DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA		1310005804				
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
						D	H	M	A
MURILLO	ZAMBRANO	NIBALDO	FABRICIO	MASCULINO	50				X

B. RESUMEN DE CUADRO CLINICO									
PACIENTE MASCULINO DE 49 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CIRUGÍA DE REPARACIÓN DE HERNIA HIATAL, CIRUGÍA ANTIRREFLUJO. PRESENTA CUADRO DE DISFAGIA, VÓMITOS, PÉRDIDA DE PESO. EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, EL CUADRO SE EXACERBO EN LOS ÚLTIMOS 20 DÍAS. INFORME DE ESOFAGOGRAMA: ESÓFAGO DILATADO DE 7 CMS CON PERSISTENCIA DEL MEDIO DE CONTRASTE. SE REALIZA ENDOSCOPIA ALTA IECED PORTOVIEJO:23/06/2025 CON HALLAZGOS ESÓFAGO CON RETENCIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS ESÓFAGO SIGMOIDEO, PROBABLE TRASTORNO MOTOR ESOFÁGICO ESTOMAGO EN RELACIÓN A SU ANTECEDENTE QUIRÚRGICO GASTROPATÍA ERITEMATOSA EN CUERPO Y ANTRO TEST DE UREASA PARA H. PYLORI NEGATIVO. MANOMETRIA 25/7/2025: AUSENCIA DE PERISTALSIS CON PRESURIZACIÓN PANESOFAGICA INDUCIDA POR LAS DEGLUCIONES. PRESIÓN BASAL NORMAL DEL ESFÍNTER ESOFAGICO INFERIOR LOS HALLAZGOS CARACTERIZAN UNA ACALASIA DEL TIPO II POR LA CLASIFICACIÓN DE CHICAGO APP: ACALASIA APF: MADRE HTA- TIO MATERNO CA DE COLON (+) APQX: CIRUGIA DE REPARACION DE HERNIA HIATAL, CIRUGIA ANTIRREFLUJO ALERGIAS: NO REFIERE LABORATORIOS : HGB 15.2 HCT 44.9 PLT 288 , TIEMPOS NORMALES , GLUCOSA 99.8, ENZIMAS HEPATICAS OK . ELECTROLITOS ELEVACIÓN DEL POTASIO EN SUERO 6.79 CLORO 95.10 SODIO 135.8 , UREA 31.6 BUN 14.7 CREATININA 1.2 VALORACIÓN CARDIOLÓGICA : RIESGO BAJO POR SCORE LEE PACIENTE EGRESA DE QUIROFANO ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE LUEGO DE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ENDOSCÓPICOS. PCTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO. SE MANTIENE ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE. CLÍNICAMENTE BIEN. ES DADA DE ALTA, SE EXPLICAN LOS RESULTADOS AL PACIENTE Y ACOMPAÑANTE. SE ENTREGAN INDICACIONES AL ALTA.									

C. RESUMEN DE EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES	
Evolución	Complicación
FAVORABLE	NINGUNA

D. HALLAZGOS RELEVANTES DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS
ACALASIA + MIOTOMIA ENDOSCÓPICA SIN COMPLICACIONES INMEDIATAS EN PACIENTE CON HELLER PREVIO.

DATOS DEL USUARIO / PACIENTE				
PRIMER APELLIDO	PRIMER NOMBRE	EDAD	NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA	NÚMERO DE ARCHIVO
MURILLO	NIBALDO	50	1310005804	

E. RESUMEN DE TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS
BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE VIDEOENDOSCOPIO TERAPEUTICO ACOPLADO AL CAP REVEAL 12.4 MM DESCARTABLE A TRAVES DEL BITE BLOCK ADULTO DESCARTABLE POR VIA ORAL. EL ESOFAGO SE ENCUENTRA DILATADO TORTUOSO CON DIFICULTAD DEL PASO DEL ENDOSCOPIO. EL ESTOMAGO MUESTRA EL TECHO NORMAL CON MORFOLOGIA DE FUNDUPLICATURA, EL CUERPO NORMAL. EL ANTRO PRESENTA ERITEMA. EL BULBO ESTA NORMAL. LA SEGUNDA PORCION SIN LESIONES. EL CARDIAS ESTA A 42CM DE LA ARCADA DENTARIA SUPERIOR APROXIMADAMENTE. SE REALIZA LAVADO DE LA MUCOSA ESOFAGICA CON UNA AMPOLLA DE GENTAMICINA DE 280MG DILUIDA EN 60 CC DE CLORURO DE SODIO . UTILIZANDO UN FLUSHKNIFE BALL TIP TYPE - 2.0 MM DK2618J-B20 DESCARTABLE ACOPLADO UNA BOMBA PLUS PARA ERBEJETT DESCARTABLE Y ESTE A SU VEZ ACOPLADO CON EL SET DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ENDOCORTE DESCARTABLE PROCEDEMOS REALIZAR UN TUNEL CON ABERTURA DE 1,5CM APROXIMADAMENTE A 7CM POR ENCIMA DEL CARDIAS SOBRE CARA POSTERIOR. LUEGO SE PROCEDE CON UNA Aguja de Esclerosis 22 G Long 4mm/ Diam catéter 2.3mm Long 2300 Estéril. Descartable A INYECTAR CLORURO DE SODIO CON AZUL DE METILENO EN LA SUBMUCOSA (6 BlueBoost Solucion inyectable para la submucosa. 10ml . Estéril) SE PROCEDE A SEGUIR REALIZANDO CORTE Y COAGULACION DE SUBMUCOSA Y COAGULACION DE LOS VASOS SANGUINEOS DE PEQUEÑO CALIBRE, HASTA COMPLETAR UN TUNEL EN LA SUBMUCOSA. CON UNA PINZA Ensure Coagulation Forceps, cucharas tapered jaw, apertura 6.5mm,Diam 2.3mm, long catéter 1650mm. Estéril, DESCARTABLE ACOPLADO AL SET DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ENDOCORTE DESCARTABLE SE CAUTERIZA VASOS SANGUINEOS DE MAYOR CALIBRE. POSTERIORMENTE SE REALIZA CORTE DE LA FIBRA MUSCULAR Y LONGITUDINAL DEL ESOFAGO HASTA LLEGAR AL CARDIAS. LUEGO SE LAVA CON UNA SEGUNDA AMPOLLA DE GENTAMICINA DE 280MG DILUIDA EN 60 CC DE CLORURO DE SODIO EL INTERIOR DEL TUNEL REALIZADO. LUEGO DE COMPRUEBA EL PASO DEL ENDOSCOPIO DESDE EL ESOFAGO A ESTOMAGO SIN NINGUNA DIFICULTAD A NIVEL DEL CARDIAS. FINALMENTE SE COLOCAN 3 Lockado Clip 16 mm Rotable, Reposicionable. Long 235 Canal de Trabajo 2.8 mm Estéril. Descartable Y 1 Lockado Clip 22 mm Rotable, Reposicionable. Long 235 Canal de Trabajo 2.8 mm Estéril. Descartable PARA CERRAR LA TOTALIDAD DEL TUNEL EVIDENCIANDOSE HEMOSTASIA Y CIERRE ADECUADO.

F. INDICACIONES DE ALTA / EGRESO
PRÓXIMO CONTROL

G. DIAGNOSTICO DE ALTA / EGRESO	CIE
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL ACALASIA DEL CARDIAS	K220
CAUSA EXTERNA	

H. CONDICIÓN DE ALTA / EGRESO	VIVO	FALLECIDO
ALTA MÉDICA ALTA VOLUNTARIA	RETIRO NO AUTORIZADO AUTORIZADO	DEFUNCIÓN MENOS DE 48 HORAS DEFUNCIÓN MAS DE 48 HORAS
X DISCAPACIDAD		DÍAS DE ESTADIA DÍAS DE REPOSO

I. MÉDICOS TRATANTES				
NOMBRE Y APELLIDOS		ESPECIALIDAD	SELLO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL	PERÍODO DE RESPONSABILIDAD
1.	Dr. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA	GASTROENTEROLOGO	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO Cedula No. 1307189140	

J. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE				
FECHA	HORA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
2025-10-11		Dr. CARLOS	ROBLES	MEDRANDA
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		FIRMA		SELLO
1307189140				Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO Cedula No. 1307189140
ELABORADO POR:	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO		REVISADO POR:	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO